

성인 Daily Day 01 — 고혈압 초진

1차진료

만성질환

KCD I10 / R03.0

작성일 2026-05-12

오늘의 목표

첫 방문에서 "진짜 고혈압인지", "오늘 약을 시작할지", "응급실/전문의로 보내야 하는지"를 결정한다. 진료실 혈압 140/90 mmHg 이상, 가정혈압 135/85 mmHg 이상을 핵심 기준으로 삼는다.

1. 배경지식

고혈압은 성인 1차의료에서 가장 반복적으로 만나는 질환이다. 초진의 핵심은 혈압 숫자 하나에 끌려가는 것이 아니라, 측정 오류와 백의고혈압을 줄이고, 표적장기손상과 2차성 고혈압 단서를 빠르게 가르는 것이다.

한국 진료 현실에서는 진료실혈압 140/90 mmHg 이상을 고혈압 기준으로 보고, 가정혈압은 135/85 mmHg 이상이면 고혈압으로 판단한다. 초진에서 반복 측정과 가정혈압 기록을 설명하는 순간부터 환자의 순응도가 갈린다.

2. 첫 3분 Triage

즉시 ER: 180/120 전후 이상 + 흉통, 호흡곤란, 신경학적 결손, 의식 변화, 시야장애, 폐부종, 급성 신손상 의심. 대동맥박리, ACS, stroke/TIA, 임신/산후 중증 고혈압도 기다리지 않는다.

- 5분 안정 후 재측정. 가능하면 양팔 측정.
- 흉통, 숨참, 한쪽 마비/말 어눌함, 시야장애, 심한 두통부터 질문.
- NSAID, 감기약, 스테로이드, 한약/보충제, 다이어트약, 음주, 수면무호흡 확인.
- 오늘 약 시작 vs 가정혈압 1주 기록 후 결정.

3. 핵심 문진 5문항

- 집에서 잤 혈압도 높았는가? 언제, 몇 번, 얼마였는가?
- 가슴통증, 숨참, 한쪽 마비, 말 어눌함, 시야 흐림, 심한 두통이 있었는가?
- 진통제, 감기약, 스테로이드, 다이어트약, 한약, 건강보조제를 복용하는가?
- 코골이/수면무호흡, 주간졸림, 최근 체중 증가가 있는가?
- 가족력, 당뇨, 신장질환, 심뇌혈관질환 병력이 있는가?

4. 꼭 해야 할 Physical Exam

- 양팔 혈압: 높은 쪽 기준. 재진부터 같은 팔로 추적.
- BMI, 허리둘레: 대사위험과 생활요법 설명에 필요.
- 심장/폐: 심잡음, S3, crackle, 심부전 소견.
- 경동맥/복부 bruit: 혈관질환, 신혈관성 고혈압 단서.
- 말초부종, 말초맥박: 심부전/신장질환/혈관질환.

5. 검사

기본 검사	목적
CBC	빈혈/동반질환 확인
Na/K/Cl, BUN/Cr/eGFR	ARB/ACEi/이뇨제 전 신기능· 전해질 기준
AST/ALT	대사질환/약제 선택 전 기준
FBS 또는 HbA1c	당뇨 동반 여부
Lipid profile	심혈관위험도와 statin 판단
Urinalysis, urine ACR	단백뇨/신장질환/표적장기손상
ECG	좌심실비대, 허혈, 부정맥 단서

6. KCD 코드

코드	상황
I10	본태성 고혈압. 진단 확인 후 치료/추적 주상병.
R03.0	고혈압 진단 없이 혈압 상승 소견. 초진·확진 전 단계.
Z13.6	심혈관질환 선별검사 맥락.
E78.x / E11.x / N18.x	지질/당뇨/CKD 동반 시 부상병.

7. 처방 Regimen

상황	약제 예	주의
일반 초진	Amlodipine 5 mg qd	부종, 홍조, 두근거림 설명
당뇨/단백뇨/CKD 경향	Losartan 50 mg qd 또는 Telmisartan 40 mg qd	K/Cr 추적, 임신 가능성 금기
160/100 이상 또는 목표보다 20/10 이상	ARB/CCB 저용량 복합제	초진부터 병합 가능. 어지럼/저혈압 설명
노인 단독수축기, 염분 섭취 많음	CCB 또는 thiazide-like	저Na/저K/요산 주의
협심증/빈맥 일부	Beta-blocker 선택 가능	천식/COPD, 서맥 주의

처방 전 체크: 임신 가능성, eGFR/Cr/K, NSAID 장기복용, 부종, 통풍/고요산혈증, 서맥/천식.

8. Follow-up

- 약 시작 전: 가정혈압 1주 기록 후 1-2주 내 재진.
- 약 시작 후: 2-4주 뒤 혈압/부작용 확인.
- ARB/ACEi/이뇨제 시작 또는 증량 후 Cr/eGFR, K 재확인.
- 목표 미달: 순응도, 염분, NSAID, 음주, 수면무호흡 확인 후 증량/병합.

9. Refer 기준

- 즉시 ER: 고혈압 응급 의심 증상 동반.
- 빠른 의뢰: Cr 급상승, 단백뇨/혈뇨, 반복 저칼륨혈증, 젊은 중증 고혈압, resistant hypertension.
- 계획 의뢰: 심부전/판막질환/수면무호흡/신장질환 동반 의심.

10. 환자 설명 스크립트

오늘 혈압이 높게 나왔지만, 한 번 잦 혈압만으로 평생 약을 결정하지는 않습니다. 다만 수치가 꽤 높거나 위험요인이 있으면 빨리 조절을 시작하는 게 안전합니다.

집에서 아침, 저녁으로 1주일 정도 재서 평균을 보겠습니다. 집 혈압이 135/85 이상으로 반복되면 진짜 고혈압 가능성이 높습니다.

혈압약은 실패가 아니라 혈관을 보호하는 치료입니다. 목적은 뇌졸중, 심근경색, 신장 손상을 줄이는 것입니다.

가슴통증, 숨참, 한쪽 마비, 말이 어눌해짐, 갑자기 심한 두통이나 시야장애가 생기면 약을 더 먹고 기다리지 말고 응급실로 가셔야 합니다.

11. 자가체크

1. 진료실 혈압과 가정혈압의 고혈압 진단 기준은?
2. 초진 고혈압 환자에서 응급실로 보낼 증상 4가지는?
3. ACEi/ARB 시작 전과 시작 후 확인해야 할 검사 2가지는?
4. R03.0과 I10을 나누는 실무 기준은?
5. Thiazide 계열을 조심해야 할 환자군 3가지는?

참고 출처

Korean Society of Hypertension 2022 focused update: <https://clinicalhypertension.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40885-023-00234-9>

KSH Home BP position statement: <https://clinicalhypertension.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40885-022-00218-1>

ACC summary of 2023 ESH guideline: <https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/Articles/2024/02/05/11/43/2023-ESH-Hypertension-Guideline-Update>